Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

# Crise d’épilepsie

Crise convulsive, épilepsie connue ou non : chronométrer, protéger sans retenir, PLS après la crise. Adulte et enfant (EHPAD, MAS, FAM, IME).

**URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT** · crise > 5 min, crises répétées sans reprise de conscience, respiration anormale ou lèvres bleues après la crise.

**Protocole individuel / PAI :** PAI prévoyant le **midazolam buccal (Buccolam)** : je le donne **à 5 min de crise**, dose et gestes du PAI, même si je suis éducateur formé ; **une seule dose** ; le 15 est appelé en même temps.

## 1 · Pendant la crise : je protège

- Je regarde l’**heure de début** (chronomètre).
- J’éloigne les objets, je protège la tête (coussin, vêtement), je desserre le col.
- Je **ne retiens pas** les mouvements ; je ne déplace pas, sauf danger.
- En fauteuil : freins serrés, je la laisse assise et je protège la tête.

## 2 · J’observe et je note

- **Durée** exacte : heure de début et de fin.
- Raideur, secousses, un côté ou tout le corps ; reprise de conscience entre deux crises ?
- Après : **glycémie capillaire** (AS/AP), T°, SpO2 ; respiration normale ?
- Fièvre, choc à la tête, morsure de langue, perte d’urines ?

## 3 · Après la crise

- Dès la fin des secousses : **PLS** (côté gauche si grossesse) ; vérifier la respiration.
- Récupération au calme ; je reste près (somnolence, confusion).
- Rien par la bouche avant le **réveil complet** et une déglutition normale.
- Crise semblable à celles décrites au PAI : suivre le PAI et prévenir l’IDE.

## Je ne fais pas

- Mettre quoi que ce soit dans la bouche (doigts, objet, eau, comprimé), **hors Buccolam prévu au PAI**.
- Retenir les membres de force, déplacer pendant la crise sauf danger.
- Donner une **2e dose** de Buccolam.
- Donner un traitement « si besoin » sans validation de l’IDE ou du médecin.

## J’alerte

**Appel 15 immédiat si :**

- Crise **> 5 min**, ou crises répétées **sans reprise de conscience**.
- Respiration anormale, lèvres bleues ; pas réveillé 30 min après.
- **Première crise** ; fièvre, choc à la tête, grossesse.
- **3 crises en 1 h** ; blessure grave.

**J’appelle l’IDE (à défaut : médecin d’astreinte ou DOTR) si :**

- Toute crise, même courte et habituelle.
- Crises plus fréquentes ou différentes de d’habitude ; récupération lente.
- Traitement antiépileptique oublié, vomi ou refusé.

## Je surveille et je trace

- Conscience et respiration jusqu’au réveil complet ; choc à la tête : « Traumatisme crânien ».
- Tracer : début, fin, description, gestes, médicament (heure, dose), récupération.
- Remettre aux secours le PAI et la **seringue vide**.

## Mention de sécurité

Chronomètre en main : à 5 min, 15 (et Buccolam si le PAI le prévoit). Rien dans la bouche, ne pas retenir, PLS dès la fin des secousses.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : SRLF/SFMU/GFRUP, RFE état de mal épileptique (2018) ; EMA, RCP Buccolam (procédure II/0061, 21/10/2024) ; OMéDIT IDF/ARS IDF, Que dit la loi sur la PECM en ESMS handicap (01/2025) ; CASF art. L.313-26 ; ARS IDF/STARAQS, fiche crise convulsive (2023) ; DGSCGC, PSC1 (12/2023).

Réf. DOTR-AS-EPI | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature